



ISO 45003: 2021

Psychological Health and Safety in the Workplace – Guidelines

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45003:ed-1:v1:en>

Made Yenny Puspitarini
2022

Turunan SMK3 di Indonesia

- SMK3L Perusahaan Minyak dan Gas
- SMK3 untuk rumah sakit
- SMK3 untuk perusahaan konstruksi
- SMK3 untuk kontraktor (CSMS)
- Indonesian Sustainable Palm Oil/ Roundtable on Sustainable Palm Oil (ISPO/ RSPO)
- SMK3 untuk kereta api
- SMK3 untuk Industri Pakaian Jadi (Better Work)
- SMK3 Perusahaan Mineral dan Pertambangan
- Clean, Health, Safety and Sustainable Environment (CHSE)– Pariwisata dan bisnis pendukungnya

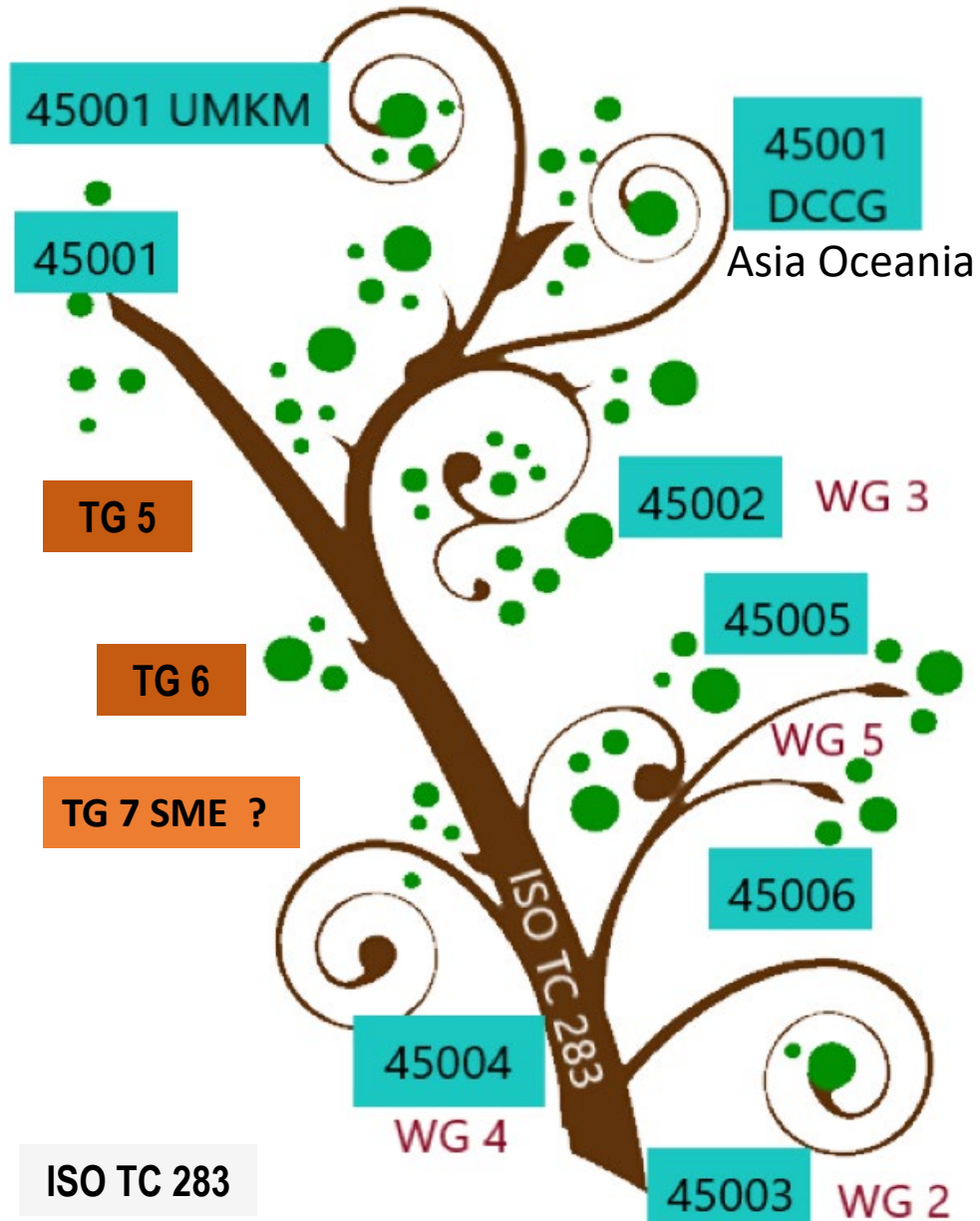


DASAR PERUNDANGAN K3

- Permenaker No. 2 / 1980 **Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja** Dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja
- Permenakertrans No 04/1980 Persyaratan Pemasangan dan Pemeliharaan **Alat Pemadam Kebakaran**
- Permenaker No. 1 / 1981 Kewajiban **Melaporkan PAK**
- Permenaker No. 3 / 198 2 **Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja**
- Permenaker No. 4 / 1987 panitia/perwakilan pekerja K3 dan Tata Cara Pengangkatan **Tenaga Ahli K3**
- Keputusan Permenaker No. 333 / 1989 Diagnosis dan Pelaporan **PAK**
- Permenaker No.2 / 1992 Tata Cara Pengangkatan Kewajiban dan Kewenangan **Ahli K3**
- KepDirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnaker No. 84/1998 Cara Pengisian **Formulir Laporan Kecelakaan dan Analisis Statistik**
- Permenaker No. 3/1998 : Prosedur **Pelaporan dan Inspeksi Kecelakaan**
- Kepmenaker No. 186 / 1999 : **Satuan Pemadam Kebakaran Tempat Kerja**
- UU Indonesia no. 13/2003 : **Ketenagakerjaan**
- Permenaker No. 15 / 2008 : **Pertolongan Pertama**
- Permenakertrans No. 08/ 2010 : **APD**
- PP No 50/ 2012 : **SMK3**
- Permenaker No. 9 / 2016 : **K3 di tempat kerja tinggi**
- Permenkes No. 70/2016 : **Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingker Industri**
- Permenaker No. 05 / 2018 : **Lingkungan Kerja K3**
- PP No. 88 / 2019 : **Kesehatan Kerja**
- Standar Nasional Indonesia 180:2021 : **APAR**
- Permen Kelautan dan Perikanan No 6/Permen-KP/2018 tentang **K3** di Lingkungan Kementerian **Kelautan dan Perikanan**
- Permenhub 85 / 2018 Sistem Manajemen **Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum**
- Permenhub 68 / 2018 Sistem Manajemen **Keselamatan Perkeretaapian**
- PerDirjen Perhubungan Udara No 83/ 2018 Pedoman **Sistem Manajemen Keselamatan** (SMS Manual)
- Kep Dirtek Minyak dan Gas Bumi dan Lingkungan K/18/DMT/2018 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan **Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas**
- Permen ESDM No. 26 / 2018; Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan **Pertambangan Mineral dan Batubara**
- Kepmen ESDM No 1827 K / 30/MEM/ / 2018 Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik **Pertambangan** yang Baik

Technical Committee

ISO TC 283 OHSMS Groups



ISO 45002 : 2020
General Guidelines on
Implementation of ISO 45001:2018

ISO 45003 : 2020
Psychological health and safety at work —
Guidelines for managing psychosocial risks

ISO 45004 : 2020
Performance evaluation

ISO PAS 45005 : 2020
Safe working during the COVID-19 pandemic —
General guidelines for organizations

ISO 45006 : 2021
Preventing & Managing Infectious Diseases

TG 5 : Auditing Practise Group

TG 6 : Review ISO 45001:2018



WG = Work Groups

TG = Task Groups

DCCG = Development Country
Coordination Group

SME = Small and Medium
Enterprises

ISO/TC 283

ISO/TC 283 is responsible for developing standards for occupational health and safety (OH&S) management.

The standards developed in this committee are applicable to organizations of all sizes, sectors and locations and should drive improvement in OH&S performance.

Number	Title	Publication date
ISO 45001	Occupational health and safety management systems - requirements	March 2018
ISO 45001 (Handbook)	A practical guide for smaller organizations	September 2020
ISO 45002	General guidelines on implementation of ISO 45001:2018	Due: October 2022
ISO 45003	Psychological Health and Safety in the Workplace – Guidelines	June 2021
ISO 45004	OH&S performance evaluation guidelines	Due: Jan. 2024
ISO PAS 45005	Safe working during the COVID-19 pandemic - Guidelines	December 2020
ISO 45006	Preventing & managing infectious diseases	Due: Dec. 2023

ISO 45001 vs 45003

ISO 45001:2018		ISO 45003 : 2021		ISO 45001:2018		ISO 45003 : 2021		ISO 45001:2018		ISO 45003 : 2021	
			Foreword	6.1.1	General	6.1	General	8	Operation	8	Operation
			Introduction		Hazard identification and assessment of risks and opportunities			8.1	Operational planning and control	8.1	Operational planning and control
1	Scope	1	Scope	6.1.2		6.2	Planning Process	8.1.1	General	8.1.1	General
2	Normative references	2	Normative references			6.2.1	Hazard identification	8.1.2	Eliminating hazards and reducing OH&S risks	8.1.2	Eliminating of hazards
3	Terms and definitions	3	Terms and definitions			6.2.1.1	Human factors			8.1.3	Substitution and engineering controls
4	Context of the organization	4	Context of the organization			6.3	Objectives to address psychosocial risk			8.1.4	Administrative controls
4.1	Understanding the organization and its context	4.1	Understanding the organization and its context							8.1.5	Personal protective equipment
4.2	Understanding the needs and expectations of workers and other interested parties			6.1.3	Determination of legal requirements and other requirements			8.1.3	Management of change	8.2	Management of change
4.3	Determining the scope of the OH&S MS			6.1.4	Planning action			8.1.4	Procurement	8.3	Procurement, contracting and outsourcing
4.4	OH&S MS				OH&S objectives and planning to achieve them			8.2	Emergency preparedness and response		
5	Leadership and worker participation	5	Leadership and worker participation	6.2.1	OH&S objectives			9	Performance evaluation	9	Performance evaluation & Management Review
				6.2.2	Planning to achieve OH&S objectives			9.1	Monitoring, measurement, analysis and performance evaluation	9.1	Monitoring, measurement, analysis and evaluation
				7	Support.	7	Support.	9.1.1	General		
5.1	Leadership and commitment	5.1	General	7.1	Resources	7.1	Resources	9.1.2	Evaluation of compliance		
5.2	OH&S policy	5.2	Policy	7.2	Competence	7.2	Competence	9.2	Internal Audit	9.2	Internal Audit
				7.3	Awareness	7.3	Awareness	9.3	Management review	9.3	Management review
5.3	Organizational roles, responsibilities and authorities			7.4	Communication	7.4	Communication	10	Improvement	10	Improvement
5.4	Consultation and participation of workers	5.3	Consultation and participation of workers	7.5	Documented information	7.5	Documented information	10.1	General	10.1	General
					General	7.6	Confidentiality	10.2	Incident, nonconformity and corrective action	10.2	Incident, nonconformity and corrective action
				7.5.1				10.2.1	Non Conformity		
				7.5.2	Creating and updating			10.2.2	Incident		
				7.5.3	Control of documented information			10.3	Continual improvement	10.3	Continual improvement

Why ISO 45003 was developed

- Aspek OH&S yang diabaikan secara historis
- Sering dianggap sulit untuk diatasi atau di luar kewenangan K3
- Tidak tercakup secara mendalam dalam ISO 45001
- Pentingnya menjadi lebih jelas bagi organisasi karena aspek lain dari K3 dikelola dengan lebih baik
- Secara inheren lebih signifikan dalam industri non-tradisional dan sektor jasa



Organisasi tidak memahami masalahnya

- Apa yang menyebabkan gangguan psikologis di tempat kerja?
- Istilah tidak dikenal - apa itu risiko 'psikososial'?
- Bagaimana kita bisa melihat bahaya?

Organisasi tidak tahu tindakan apa yang harus diambil

- Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Kami bukan ahli dalam hal ini...
- Bagaimana kita bisa mengatasinya dalam budaya yang secara tradisional tidak terbuka tentang ini?
- Bagaimana kita bisa mengatasi dampak dari luar pekerjaan?

Tanda-tanda paparan risiko psikososial – tingkat individu atau kelompok

Meningkatnya tingkat ketidakhadiran dari pekerjaan

Masuk kerja saat sakit

Pergantian staf yang tinggi

Kinerja berkualitas rendah atau kegagalan memenuhi tenggat waktu

Kurangnya keterlibatan (pekerja)

Konflik, kurangnya kemauan untuk bekerja sama

Penindasan, pelecehan, diskriminasi

Berkurangnya keinginan untuk bekerja dengan orang lain

Peningkatan jumlah kesalahan atau insiden

Pentingnya budaya organisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan psikologis :

Keamanan keuangan

Interaksi sosial

Penyertaan (minoritas)

Pengakuan dan penghargaan

Pengembangan pribadi

Kesempatan yang sama

Keadilan & perlakuan yang sama

Tingkat kontrol dan otonomi

Keterbukaan untuk diskusi, umpan balik, dan menyampaikan kekhawatiran

Membangun Budaya Keamanan & Kepercayaan Psikologis

- Hanya ada satu budaya dalam sebuah organisasi: keamanan psikologis dan kepercayaan dipengaruhi oleh budaya yang lebih luas
- Budaya didorong oleh manajer di semua tingkatan: pemimpin harus menunjukkan perilaku yang ingin mereka lihat
- Setiap orang, terlepas dari status atau perannya, dapat berkontribusi untuk membangun keamanan dan kepercayaan serta memengaruhi bagaimana budaya berkembang
- Transparansi, keterbukaan, keadilan, dan pendekatan tanpa menyalahkan sangat penting
- Para pemimpin harus berbicara tentang bagaimana kesejahteraan pekerja merupakan hal mendasar bagi keberhasilan organisasi
- Pemimpin harus menunjukkan keterbukaan tentang masalah dan mendorong dialog
- Pekerja di semua tingkatan dapat mendukung dan mendorong ini dengan menunjukkannya melalui dukungan sebaya
- Fokus pada intervensi organisasi yang mengatasi menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko daripada ketahanan individu dan rehabilitasi
- Fokus pada mengidentifikasi akar penyebab daripada menyalahkan individu atas insiden

Kepemimpinan

Bicara tentang bagaimana kesejahteraan pekerja sangat penting bagi keberhasilan organisasi

Secara nyata mendukung dan berkontribusi untuk mengelola risiko psikososial dan meningkatkan kesejahteraan

Menyediakan sumber daya yang diperlukan, termasuk pelatihan

Sertakan pengelolaan risiko psikososial dalam kebijakan dan rencana strategis

Pastikan kebijakan koheren dan tidak bertentangan satu sama lain

Pastikan tim dan peran yang berbeda bekerja sama untuk mengelola kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan psikologis

Mempromosikan budaya peduli dan kepercayaan

Lindungi pekerja dari pembalasan saat melaporkan masalah atau insiden

Pemimpin harus menunjukkan keterbukaan tentang masalah dan mendorong dialog

Fokus pada mengidentifikasi akar penyebab daripada menyalahkan individu atas insiden

Fokus pada intervensi organisasi yang menangani menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko daripada ketahanan individu dan rehabilitasi

Konsultasi dan partisipasi pekerja

Pastikan bahwa pekerja memiliki cara untuk memberikan umpan balik tentang risiko dan tindakan yang diambil untuk mengelolanya

Mendorong dan mendukung pekerja di semua tingkatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Libatkan pekerja dalam perencanaan serta implementasi – jangan menunggu sampai keputusan telah dibuat untuk berkonsultasi dengan pekerja

Pastikan tindakan diambil untuk melindungi kerahasiaan

Mendukung dan mendorong pembentukan dan penggunaan komite kesehatan dan keselamatan, kelompok sesama pekerja, perwakilan pekerja

Psychosocial risks can arise from:

Bagaimana pekerjaan diatur	
Peran & harapan	• ambiguitas peran atau konflik • tuntutan yang bertentangan • perubahan tugas/tanggung jawab
Kontrol dan tuntutan pekerjaan	• masukan terbatas untuk pengambilan keputusan • kurang kontrol • paparan situasi traumatis
Beban kerja, kecepatan kerja, jam kerja	• kerja shift / jam kerja yang panjang atau tidak ramah • jam yang tidak fleksibel atau tidak dapat diprediksi • pemberitahuan singkat / tenggat waktu yang ketat
Kerja jarak jauh & isolasi	• bekerja jauh dari rumah, keluarga, teman • bekerja tanpa interaksi sosial • bekerja di rumah pribadi
Keamanan kerja	• bekerja tanpa jam yang ditentukan • kemungkinan redundansi atau pengurangan gaji • pekerjaan tidak standar

TIPS

Beban kerja:

Tingkatkan dukungan dari manajer dan rekan kerja, tawarkan pelatihan, lapor masuk dan mengobrol, sesuaikan peran untuk berbagi beban kerja antar pekerja

Jam kerja dan kecepatan kerja:

Berikan jam kerja dan waktu istirahat yang fleksibel, kontrol yang lebih besar atas kecepatan dan tenggat waktu, dorong istirahat yang teratur

Ambiguitas dan kejelasan peran:

Berikan informasi yang jelas tentang tugas, apa yang diharapkan, bantuan apa yang tersedia

Kurangnya kontrol:

Biarkan pekerja berbicara tentang kecemasan mereka, bekerja sama untuk menemukan solusi, biarkan lebih banyak kontrol atas bagaimana sesuatu dilakukan

Psychosocial risks can arise from:

Faktor sosial di tempat kerja (contoh bahaya)

Hubungan interpersonal	• komunikasi/pembagian informasi yang buruk • konflik interpersonal, hubungan kekuasaan yang tidak setara • pelecehan, intimidasi, viktimisasi
Kepemimpinan & budaya	• penyalahgunaan atau penyalahgunaan kekuasaan, • kurangnya kepercayaan, kejujuran, keadilan • gagal mendengarkan/menindaklanjuti keluhan dan saran • tidak konsisten dan/atau pengambilan keputusan yang buruk
Keseimbangan kerja/hidup	• pekerja perlu bekerja di waktu mereka sendiri • tuntutan pekerjaan dan rumah yang saling bertentangan • pekerjaan yang berdampak pada kemampuan pekerja untuk pulih
Kekerasan, pelecehan, diskriminasi	• pelecehan atau ancaman • kekerasan fisik, verbal atau seksual, kekerasan berbasis gender • pemanggilan nama, gosip jahat, kritik yang tidak semestinya

TIPS

Kurangnya dukungan sosial:
Obrolan satu lawan satu atau panggilan video reguler yang sesuai dengan individu; pertemuan sosial opsional melalui video; tanya ada apa di rumah

Ketidakamanan kerja:
Mendorong diskusi terbuka, bekerja sama untuk menemukan solusi, bersikap transparan dan berbagi informasi lebih awal

Pengembangan karir:
Berbagi informasi tentang sumber daya pelatihan dan pengembangan, mendorong pendampingan dan pembinaan

Kelompok pekerja tertentu:
Dengarkan kecemasan individu, tawarkan langkah-langkah keamanan tambahan untuk kelompok rentan yang diketahui, bersikap suportif dan fleksibel

Psychosocial risks can arise from:

Lingkungan kerja, peralatan & tugas berbahaya (contoh bahaya)

Peralatan	• kesesuaian, keandalan, pemeliharaan atau perbaikan peralatan yang tidak memadai • kurangnya alat yang diperlukan, peralatan atau sumber daya lainnya
Kondisi tempat kerja	• kurangnya ruang, pencahayaan yang buruk, kebisingan yang berlebihan • suhu yang sangat tinggi atau rendah • bekerja di ketinggian
Lingkungan tempat kerja	• lingkungan yang tidak stabil, seperti zona konflik

TIPS

Peralatan:

Memastikan pekerja memiliki alat yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Akui setiap masalah dan berikan informasi yang jelas tentang kapan masalah ini dapat diatasi.

Kondisi tempat kerja:

Dengarkan kekhawatiran dan berkolaborasi dengan pekerja untuk menciptakan kondisi kerja sebaik mungkin, baik ini di lokasi yang dikendalikan oleh organisasi atau tempat kerja jarak jauh

Lingkungan tempat kerja:

Berikan dukungan ekstra untuk pekerja dalam situasi yang tidak stabil atau berpotensi bergejolak. Dengarkan kekhawatiran dan tanggapilah dengan serius. Memfasilitasi istirahat yang teratur dan memadai dari pekerjaan, keluar dari lingkungan yang sulit

Menerapkan proses untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko psikososial

Intervensi primer	Tingkat pengendalian organisasi untuk mencegah atau mengurangi bahaya dan meningkatkan kesejahteraan
	Buat keputusan tentang perubahan di tempat kerja sebagai sebuah tim – libatkan mereka yang terkena dampak
	Meningkatkan tingkat kontrol yang dimiliki pekerja atas pekerjaan (misalnya fleksibilitas seputar bagaimana dan kapan)
	Menghilangkan bahaya pada sumbernya (misalnya mengatur ulang pekerjaan untuk menghilangkan kelebihan beban)
Intervensi sekunder	Tingkatkan sumber daya untuk membantu pekerja memahami dan mengelola risiko
	Tingkatkan kesadaran, perbaiki budaya, kurangi stigma seputar kesehatan psikologis
	Berikan pelatihan dan dukungan, dorong pelaporan
Intervensi tersier	Mengurangi efek berbahaya dari paparan bahaya psikososial
	Program rehabilitasi
	Intervensi individu

DEFINISI :

3.1 Risiko psikososial

Kombinasi dari kemungkinan terjadinya pajanan terhadap bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersifat psikososial dan tingkat keparahan cedera dan kesehatan yang buruk yang dapat disebabkan oleh bahaya ini

Catatan 1 : Bahaya yang bersifat psikososial mencakup aspek organisasi kerja, faktor sosial di tempat kerja, lingkungan kerja, peralatan, dan tugas berbahaya.

3.2 Kesejahteraan di tempat kerja

Pemenuhan kebutuhan dan harapan fisik, mental, sosial dan kognitif seorang pekerja terkait dengan pekerjaannya

Catatan 1 : Kesejahteraan di tempat kerja juga dapat berkontribusi pada kualitas hidup di luar pekerjaan.

Catatan 2 : Kesejahteraan di tempat kerja berkaitan dengan semua aspek kehidupan kerja, termasuk organisasi kerja, faktor sosial di tempat kerja, lingkungan kerja, peralatan, dan tugas berbahaya

4. Konteks Organisasi

4.1. Memahami organisasi dan konteksnya

4.1.1. Umum

Sehubungan dengan pengelolaan risiko psikososial, organisasi harus:

- a) Mempertimbangkan masalah eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan dari manajemen K3 sistem;
- b) Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya yang relevan Para Pihak;
- c) Mempertimbangkan kebutuhan dan harapan mana yang merupakan, atau dapat menjadi, persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
- d) Menyesuaikan desain kegiatan untuk mengelola risiko psikososial agar sesuai dengan konteks spesifik tempat kerja;
- e) Menyesuaikan kegiatan untuk memperbaiki fokus, keandalan, keabsahan dan efektivitas proses untuk mengelola risiko psikososial;
- f) Menentukan bagaimana penilaian risiko psikososial akan digunakan untuk mengefektifkan rencana pengendaliannya.

4.1.2 Isu Eksternal

Organisasi harus menentukan masalah eksternal yang relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3 dalam kaitannya dengan risiko psikososial. Masalah eksternal dapat mencakup:

- a) Rantai pasokan tempat organisasi beroperasi, karena hal ini dapat memengaruhi bahaya psikososial dan milik mereka terkait risiko (misalnya melalui tekanan terhadap target waktu, jadwal atau tekanan produksi);
- b) Hubungan dengan kontraktor, subkontraktor, pemasok, penyedia dan pihak berkepentingan lainnya;
- c) Berbagi tempat kerja, sumber daya dan peralatan dengan pihak lain (misalnya jika organisasi bekerja sama dengan organisasi lain di tempat kerja);
- d) Persyaratan pelanggan dan/atau klien untuk penyediaan layanan (misalnya persyaratan pelanggan/klien bisa memengaruhi psikososial bahaya melalui kekerasan, gangguan, target waktu);
- e) Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi ketersediaan, durasi dan lokasi; bekerja;
- f) Sifat kontrak kerja, remunerasi, kondisi kerja dan hubungan industri;
- g) Demografi pekerja yang tersedia untuk bekerja (misalnya pekerja muda atau lanjut usia, peningkatan usia pensiun, jenis kelamin);
- h) Perubahan teknologi yang cepat (misalnya peningkatan konektivitas ke perangkat elektronik, dampak kecerdasan buatan dan otomatisasi teknologi);
- i) Mobilitas angkatan kerja, menciptakan keragaman yang lebih besar di antara pekerja dengan latar belakang dan budaya yang berbeda, dan berbicara secara berbeda bahasa;
- j) Konteks yang lebih luas dari wilayah geografis organisasi, termasuk masalah sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat (misalnya pandemi, bencana alam, keuangan krisis).

4.1.3. Isu Internal

Masalah internal yang dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3 dalam kaitannya dengan risiko psikososial dapat mencakup:

- a) Bagaimana organisasi diatur dan dikelola (misalnya struktur organisasinya, penetapan peran dan tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan formal dan informal, budaya organisasi, gaya manajemen, gaya komunikasi, menghormati pribadi);
- b) Tingkat komitmen dan arahan organisasi sehubungan dengan kesehatan psikologis, keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja, sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan kebijakan, pedoman, tujuan dan strategi;
- c) Sistem manajemen lain yang diadopsi oleh organisasi yang dapat berinteraksi dengan manajemen risiko psikososial (misalnya berdasarkan [iso 9001](#) dan [iso 14001](#));
- d) Ukuran dan kondisi dari itu organisasi tenaga kerja (misalnya besar, kecil, kompleks atau sangat terdesentralisasi);
- e) Karakteristik pekerja dan angkatan kerja (misalnya jenis kelamin, usia, suku, agama, disabilitas, bahasa, melek huruf dan berhitung);
- f) Kompetensi pekerja untuk mengenali bahaya psikososial dan mengelola risiko;
- g) Lokasi kerja (misalnya tenaga kerja keliling tanpa tempat kerja tetap, bekerja dari jarak jauh, bekerja di rumah, bekerja dalam isolasi atau bekerja di lokasi terpencil seperti pedesaan);
- h) Syarat dan ketentuan pekerja (misalnya pengaturan kerja yang fleksibel, kompensasi dan tunjangan, paruh waktu, kasual atau sementara) tenaga kerja);
- i) Kecukupan dan ketersediaan sumber daya (lihat [7.1](#)).

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya

Sehubungan dengan pengelolaan risiko psikososial, organisasi harus memahami dan menentukan kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya.

Pekerja dan pihak berkepentingan lainnya memiliki berbagai kebutuhan dan harapan yang dapat dipengaruhi oleh risiko psikososial di tempat kerja. Kebutuhan dan harapan ini dapat mencakup:

- keuangan keamanan;
- interaksi sosial dan mendukung;
- penyertaan, pengakuan, penghargaan, dan prestasi;
- pengembangan pribadi dan pertumbuhan;
- kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil di bekerja.

Kebutuhan dan harapan dapat dimasukkan dalam persyaratan hukum (misalnya K3 dan undang-undang hak asasi manusia), perjanjian bersama, dan perjanjian sukarela dan persyaratan lain yang diikuti atau dipatuhi oleh organisasi.

4.3 Menentukan ruang lingkup Sistem Manajemen K3

Organisasi harus memastikan bahwa ruang lingkup sistem manajemen K3 dan operasi serta aktivitasnya sehubungan dengan manajemen risiko psikososial secara khusus ditangani oleh sistem manajemen K3 organisasi.

4.4 Sistem Manajemen K3

Organisasi harus memastikan bahwa sistem manajemen K3 tetap sesuai, efektif dan relevan dengan operasi dan aktivitasnya sehubungan dengan manajemen risiko psikososialnya.

5. Kepemimpinan dan pekerja partisipasi

5.1 Kepemimpinan dan komitmen

Keberhasilan pengelolaan risiko psikososial memerlukan komitmen di seluruh organisasi. Manajemen puncak harus memimpin ini, dan manajer dan pekerja di semua tingkatan harus membantu dalam pelaksanaannya. Manajemen puncak harus:

- a) Menunjukkan kepemimpinan dan komitmen untuk mengelola risiko psikososial dan untuk mempromosikan kesejahteraan di bekerja;
- b) Mengenali, memantau dan menjadi menyadari dari nya peran dan tanggung jawab dengan menghormati ke mengelola psikososial risiko;
- c) Menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan membuatnya tersedia secara tepat waktu dan efisien tata krama;
- d) Memperkuat keberlanjutan pengelolaan psikososial dengan mengikutsertakan rencana strategis dan sistem yang ada, proses dan struktur pelaporan;
- e) Melindungi pekerja dari pembalasan dan/atau ancaman pembalasan untuk pelaporan insiden, bahaya, risiko dan peluang;
- f) Mengomunikasikan bagaimana pelapor, korban, saksi dan mereka yang melaporkan atau mengangkat masalah risiko psikososial di tempat kerja akan terlindungi;
- g) Memperoleh dan memberikan umpan balik untuk menentukan efektivitas pengelolaan dan pencegahan risiko psikososial dalam sistem manajemen k3, baik dalam implementasi maupun operasionalnya;
- h) Memberdayakan pekerja dan memastikan mereka kompeten untuk memenuhi peran dan tanggung jawab mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola psikososial mempengaruhi;
- i) Menghilangkan hambatan yang dapat membatasi partisipasi pekerja, dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi;
- j) Secara aktif melibatkan pekerja dalam dialog berkelanjutan tentang pengelolaan resiko psikososial;
- k) Mendukung dan mendorong pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja

5.2 Kebijakan K3

5.2.1. Dalam menetapkan kebijakan K3 untuk organisasi, manajemen puncak sebaiknya:

- a) Memastikan komitmen untuk mencegah PAK dan cedera akibat psikososial risiko dan mempromosikan kesejahteraan di tempat kerja termasuk dalam kebijakan SMK3;
- b) Menentukan diperlukan kebijakan terpisah tentang pengelolaan resiko psikososial;
- c) Mempertimbangkan bagaimana kebijakan lainnya (misalnya sumber daya manusia, perusahaan penanggung jawab sosial/ BPJS) mendukung dan konsisten dengan kebijakan K3 untuk mencapai tujuan bersama.

5.2.2 Kebijakan K3 sebaiknya:

- a) Sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks dari organisasi;
- b) Termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja, termasuk komitmen untuk mengelola resiko psikososial;
- c) Menyediakan sebuah kerangka untuk mengatur dan meninjau, mengevaluasi dan merevisi tujuan untuk manajemen resiko psikososial;
- d) Mempromosikan dan meningkatkan lingkungan kerja yang konsisten dengan prinsip-prinsip martabat, saling menghormati, kerahasiaan, kerjasama dan kepercayaan dalam Sistem Manajemen K3;
- e) Dikomunikasikan kepada semua pekerja agar mereka sadar akan hak-hak dan tanggung jawab mereka;
- f) Ditinjau secara berkala untuk memastikannya tetap relevan dan sesuai dengan organisasi.

Organisasi harus berkonsultasi dengan pekerja dan, jika ada, perwakilan pekerja dalam pengembangan kebijakan untuk mengelola risiko psikososial dan, jika relevan, berkonsultasi dengan pihak berkepentingan lainnya.

Kebijakan yang terkait dengan risiko psikososial dapat memberikan arahan untuk menerapkan dan meningkatkan manajemen risiko psikososial dalam sistem manajemen K3 secara umum. Kebijakan tersebut dapat memungkinkan manajemen puncak dan pekerja lainnya untuk memahami keseluruhan komitmen organisasi dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi tanggung jawab individu. Organisasi harus mempertimbangkan apakah diperlukan kebijakan khusus untuk mengelola risiko psikososial.

5.3. Peran, tanggung jawab dan kewajiban Organisasi

Manajemen puncak bertanggung jawab atas berfungsinya sistem manajemen K3 dan harus memperjelas peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola risiko psikososial di tempat kerja. Manajemen risiko psikososial yang efektif di tempat kerja membutuhkan pekerja dengan peran berbeda untuk bekerja sama secara efektif (misalnya sumber daya manusia, manajer lini, pekerja dengan tanggung jawab K3 spesifik).

Organisasi harus mempromosikan dan mendukung keterlibatan pekerja dalam mengelola risiko psikososial secara aktif.

5.4. Konsultasi dan partisipasi dari pekerja

Konsultasi dan partisipasi pekerja dan, jika ada, perwakilan pekerja sangat penting untuk pengembangan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dari tempat kerja yang sehat dan aman serta keberhasilan proses untuk mengelola risiko psikososial.

Selain persyaratan umum dalam [ISO 45001:2018, 5.4](#), organisasi harus:

- a) Menyediakan peluang untuk mendapatkan masukan dari pekerja untuk membantu organisasi menentukan efektivitas pengelolaan resiko psikososial;
- b) Mendorong partisipasi dan keterlibatan, misalnya dalam komite kesehatan dan keselamatan atau jaringan dukungan jika sesuai dengan ukuran dan konteks organisasi. Dalam organisasi yang lebih kecil, di mana perwakilan pekerja formal mungkin kurang, proses konsultasi ini harus dilakukan secara langsung dengan pekerja. Konsultasi antara organisasi dan pekerja harus dilakukan pada semua tahap pengelolaan risiko psikososial, dengan mempertimbangkan pengalaman dan keahlian pekerja. Baik organisasi maupun pekerjanya memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Komite kesehatan dan keselamatan, dewan kerja atau badan perwakilan lainnya juga memiliki peran penting.

Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan komitmen pekerja untuk berkontribusi pada tempat kerja yang sehat dan aman secara psikologis. Didorong dan didukung untuk berpartisipasi, daripada merasa dipaksa untuk mengambil bagian, lebih mungkin efektif dan berkelanjutan.

Beberapa kekhawatiran tentang mempekerjakan pekerja dapat mencakup kekhawatiran tentang penolakan, sikap negatif, apatis, dan sifat sensitif dari dampak bahaya psikososial. Kekhawatiran ini dapat berasal dari inisiatif masa lalu yang gagal. Untuk alasan ini, perhatian harus diberikan untuk mengatasi masalah pekerja dan pihak berkepentingan lainnya saat membangun sistem manajemen K3, dan partisipasi serta konsultasi harus didorong. Melibatkan perwakilan pekerja, jika ada, dapat membantu mencegah atau meminimalkan kekhawatiran pekerja.

Organisasi juga harus mendukung konsultasi, partisipasi dan keterlibatan yang berkelanjutan, dan mendapatkan masukan di semua tahap perencanaan dan implementasi. Keterlibatan aktif dan bermakna dari pihak yang berkepentingan yang relevan adalah faktor penting untuk pengelolaan psikososial risiko di setiap organisasi.

6. Perencanaan

4. Perencanaan

6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang

6.1.1. Umum

6.1.1.1. Organisasi harus mempertimbangkan isu-isu yang dirujuk dalam [Klausul 4](#) dan menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani, termasuk:

- a) Bahaya psikososial ;
- b) Pencegahan cedera dan kesehatan yang buruk;
- c) Strategi untuk pekerja kembali ke bekerja;
- d) Peluang untuk perbaikan, termasuk promosi kesejahteraan di tempat kerja;
- e) Pengembangan, tinjauan dan pemeliharaan sistem, proses dan struktur pelaporan yang relevan dengan pengelolaan resiko psikososial.

Organisasi harus memprioritaskan tindakan berdasarkan penilaian risiko psikososial

6.1.1.2. Organisasi harus menggunakan proses perencanaan untuk:

- a) Menetapkan tujuan yang sesuai;
- b) Menentukan bagaimana mencapai tujuan pengelolaan risiko psikososial dan memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
- c) Menunjukkan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan, jika mungkin, melebihi memenuhi hukum persyaratan.

6.1.1.3. Selama proses perencanaan, organisasi harus mempertimbangkan: Akun:

- a) Kebutuhan dan harapan kelompok pekerja tertentu (misalnya pekerja yang bekerja sendiri, pekerja jarak jauh, minoritas kelompok);
- b) Kebutuhan tempat kerja atau rangkaian operasi atau pekerjaan tertentu tugas;
- c) Hasil penilaian risiko psikososial, untuk memahami sifat mereka dan yang mendasarinya penyebab;
- d) Itu penerapan dari tindakan dirancang ke menghapuskan bahaya psikososial dan mengurangi risiko terkait;
- e) Evaluasi tindakan tersebut dan hasil;
- f) Manajemen proses dengan meninjau dan memperbaruinya untuk memenuhi kebutuhan yang berubah, mengenali kebaikan praktek;
- g) Sumber daya diperlukan;
- h) Bagaimana melibatkan pekerja secara aktif melalui konsultasi dan partisipasi.

6. Perencanaan

6.1.2. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang

6.1.2.1. Identifikasi Bahaya

6.1.2.1.1. Organisasi sebaiknya:

- a) Memahami dasar sumber bahaya sebelum kontrol pengukuran dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan resiko psikososial;
- b) Mendirikan, melaksanakan dan menjaga proses untuk identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dan proaktif.

6.1.2.1.2. Organisasi harus mengidentifikasi bahaya yang bersifat psikososial. Ini bisa termasuk:

- a) Aspek bagaimana pekerjaan diatur (misalnya, lihat [tabel 1](#));
- b) Faktor sosial di tempat kerja (misalnya, lihat [Tabel 2](#));
- c) Lingkungan kerja, peralatan dan tugas-tugas berbahaya (sebagai contoh, lihat [tabel 3](#)).

Tabel 1 — Aspek bagaimana pekerjaan diatur

Contoh	
Peran dan harapan	• peran ambigu • peran konflik • tugas merawat orang lain • skenario di mana pekerja tidak memiliki pedoman yang jelas tentang tugas yang diharapkan mereka lakukan (dan tidak dilakukan) • harapan di dalam sebuah peran yang bertolak belakang satu sama lain (misalnya diharapkan untuk menyediakan layanan pelanggan yang, tetapi juga untuk tidak menghabiskan waktu lama dengan pelanggan) • ketidakpastian tentang, atau seringnya perubahan pada, tugas dan pekerjaan standar • melakukan pekerjaan yang bernilai atau tujuan kecil
Kontrol pekerjaan atau otonomi	• kesempatan terbatas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan • kurangnya kendali atas beban kerja • rendahnya level pengaruh dan kebebasan (misalnya tidak dapat untuk mempengaruhi kecepatan, pesanan, atau jadwal tugas dan beban kerja)
Tuntutan pekerjaan	• kurang dimanfaatkan keterampilannya • terpapar kerja terus-menerus untuk interaksi dengan orang-orang (misalnya publik, pelanggan, siswa, pasien) • memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu tertentu atau dengan jumlah yang ditentukan pekerja • tuntutan yang saling bertentangan dan tenggat waktu • harapan yang tidak realistis dari kompetensi pekerja atau tanggung jawab • kurangnya variasi tugas atau kinerja yang sangat berulang tugas • terfragmentasi atau bekerja tidak berarti
•	• persyaratan untuk periode kewaspadaan yang berlebihan dan konsentrasi • bekerja dengan orang yang agresif atau tertekan • terpapar peristiwa atau situasi yang dapat menyebabkan trauma
Manajemen perubahan organisasi	• kurangnya dukungan praktis yang diberikan untuk membantu pekerja selama masa transisi • restrukturisasi yang berkepanjangan atau berulang • kekurangan dari konsultasi dan komunikasi tentang perubahan tempat kerja, atau konsultasi dan komunikasi yang berkualitas buruk, tidak tepat waktu atau tidak berarti

Contoh	
Pekerjaan jarak jauh dan terisolasi	- bekerja di lokasi itu adalah jauh dari rumah, keluarga, teman-teman dan biasa mendukung jaringan (misalnya pekerjaan terisolasi atau pengaturan pekerjaan "fly-in-fly-out") - bekerja sendiri di lokasi yang tidak terpencil tanpa interaksi sosial/manusia di tempat kerja (misalnya bekerja di rumah,) - bekerja di rumah pribadi (misalnya memberikan perawatan atau peran domestik di rumah orang lain)
Beban kerja dan kecepatan kerja	- kelebihan beban kerja atau kurang beban - tingkat waktu yang tinggi tekanan - terus menerus tunduk pada tenggat waktu - mesin mondar-mandir - bekerja dengan pengulangan terus-menerus
Jam kerja dan jadwal	- kurangnya variasi bekerja - bekerja shift - pekerjaan dengan jadwal yang tidak fleksibel - jam kerja tak terduga - jam kerja panjang atau tidak ramah - pekerjaan terfragmentasi atau pekerjaan yang tidak berarti - persyaratan terus-menerus untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat
Keamanan kerja dan pekerjaan tidak tetap	- ketidakpastian mengenai ketersediaan pekerjaan, termasuk pekerjaan tanpa pengaturan jam - kemungkinan redundansi atau kehilangan pekerjaan sementara dengan pengurangan pembayaran - pekerjaan bergaji rendah atau tidak aman, termasuk pekerjaan yang tidak standar - bekerja dalam situasi yang tidak tercakup atau dilindungi dengan baik oleh undang-undang perburuhan atau perlindungan sosial

Tabel 2 — Faktor sosial di tempat kerja

Contoh	
Hubungan interpersonal	- komunikasi yang buruk, termasuk pembagian informasi yang buruk - hubungan yang buruk di antara manajer, pengawas, rekan kerja, dan klien atau yang lain dimana pekerja berinteraksi dengannya - konflik antar pribadi

Contoh

	• gangguan, intimidasi, pembohongan (termasuk menggunakan elektronik peralatan seperti sebagai surel dan sosial media), kekerasan pihak ketiga • kurangnya dukungan sosial • hubungan kekuasaan yang tidak setara antara kelompok pekerja dominan dan non-dominan • isolasi sosial atau fisik
Kepemimpinan	• kurangnya <u>visi</u> dan <u>tujuan</u> yang jelas • gaya manajemen yang tidak sesuai dengan sifat dan tuntutan pekerjaan • gagal mendengarkan atau hanya mendengarkan keluhan dan saran dengan santai • pemotongan informasi • menyediakan komunikasi dan dukungan yang tidak memadai • kurangnya pertanggungjawaban • kurangnya keadilan • pengambilan keputusan yang tidak konsisten dan praktek yang buruk • penyalahgunaan atau penyalahgunaan kekuatan
Budaya organisasi/kelompok kerja	• komunikasi yang <u>buruk</u> • tingkat dukungan yang rendah untuk pemecahan masalah dan perkembangan pribadi • kurangnya <u>penjelasan</u>, atau kesepakatan, <u>tujuan</u> organisasi • penerapan kebijakan dan prosedur yang tidak konsisten dan tidak tepat waktu, pengambilan keputusan yang tidak adil
• Pengakuan dan Penghargaan	• ketidakseimbangan antara upaya pekerja dan pengakuan formal dan informal dan penghargaan • kekurangan dari pengakuan yang sesuai dan apresiasi dari upaya pekerja <u>secara</u> adil dan tepat waktu
• Karier perkembangan	• karier stagnasi dan ketidakpastian, kurang promosi atau promosi berlebihan, kekurangan dari peluang untuk pengembangan keterampilan
• Mendukung	• kurangnya dukungan dari supervisor dan rekan kerja • kurangnya akses ke dukungan jasa • kurangnya informasi/pelatihan untuk mendukung <u>kinerja</u> pekerjaan

Contoh	
Pengawasan	• kurangnya umpan balik dan evaluasi kinerja yang konstruktif proses • kurangnya dorongan/pengakuan • kurangnya komunikasi • kurangnya visi organisasi bersama dan tujuan yang jelas • kurangnya dukungan dan/atau sumber daya untuk memfasilitasi perbaikan dalam pertunjukan • kurangnya keadilan • penyalahgunaan pengawasan digital
Kesopanan dan rasa hormat	• kurangnya kepercayaan, kejujuran, rasa hormat, kesopanan dan keadilan • kekurangan penghormatan dan pertimbangan dalam interaksi antar pekerja, seperti halnya dengan pelanggan, klien dan publik
Keseimbangan kerja/hidup	• tugas kerja, peran, jadwal, atau harapan yang menyebabkan pekerja terus bekerja sendiri • tuntutan pekerjaan yang saling bertentangan dengan rumah • pekerjaan yang memengaruhi kemampuan pekerja untuk pulih
Kekerasan di tempat kerja	• insiden yang melibatkan tantangan eksplisit atau implisit terhadap kesehatan, keamanan atau kesejahteraan pada bekerja; kekerasan dapat dimulai dari internal, eksternal atau klien, misalnya: ○ melecehkan ○ ancaman ○ penyerangan (fisik, verbal atau seksual) ○ berbasis gender kekerasan
Gangguan	• tidak diinginkan, menyinggung, mengintimidasi perilaku (seksual atau non-seksual) yang berhubungan ke satu atau karakteristik yang lebih spesifik dari individu yang ditargetkan, misalnya: ○ balapan ○ identitas gender ○ agama atau keyakinan ○ Orientasi seksual ○ disabilitas ○ usia

Contoh	
Penindasan dan viktimisasi	• pengulangan (lebih dari sekali) perilaku yang keterlaluan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, keamanan dan kesejahteraan di tempat kerja; perilaku dapat terbuka atau terselubung, misalnya: — sosial atau isolasi fisik — penugasan yang tidak berarti atau tidak menguntungkan — pemanggilan nama, hinaan, dan intimidasi — merusak perilaku — kritik publik yang tidak semestinya — menahan informasi atau sumber daya yang penting bagi seseorang pekerjaan — rumor jahat atau bergosip — menetapkan tenggat waktu yang mustahil
CATATAN 1 Berbagai kebijakan, legislasi dan praktik dapat diterapkan terkait dengan isu-isu dalam tabel ini. Berkonsultasi dengan panduan dan/atau undangundang yang relevan adalah bagian dari pemahaman persyaratan hukum dan persyaratan lainnya (lihat ISO 45001:2018, 6.1.3). CATATAN 2 Penindasan dan pelecehan dapat terjadi baik secara tatap muka maupun secara elektronik (misalnya media sosial).	

Tabel 3 — Lingkungan kerja, peralatan, dan tugas berbahaya

Contoh	
Lingkungan kerja, peralatan dan tugas berbahaya	— ketaktersediaan peralatan yang memadai, sesuai, andal, pemeliharaan atau perbaikan — kondisi tempat kerja yang buruk seperti kurangnya ruang, pencahayaan yang buruk dan kebisingan berlebihan — kurangnya alat, peralatan, atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaantugas — bekerja dalam kondisi atau situasi ekstrem, seperti suhu yang sangat tinggi atau rendah, atau di ketinggian — bekerja di lingkungan yang tidak stabil seperti zona konflik

6. Perencanaan

6.1.2.1.3. Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang berkelanjutan dan proaktif untuk mengidentifikasi bahaya psikososial. Hal ini dapat dilakukan dengan, untuk contoh:

- a) Meninjau pekerjaan deskripsi;
- b) Menganalisis tugas kerja, jadwal dan lokasi;
- c) Berkonsultasi dengan pekerja, klien dan pihak berkepentingan lainnya dengan interval secara teratur;
- d) Menganalisis evaluasi kinerja, survei pekerja, kuesioner standar, audit, dll;
- e) Mengadakan wawancara, diskusi kelompok atau menggunakan daftar Periksa;
- f) Melakukan inspeksi tempat kerja dan pengamatan yang membantu untuk memahami bagaimana pekerjaan dilakukan, dan bagaimana pekerja berinteraksi dengan lain;
- g) Meninjau informasi terdokumentasi yang relevan seperti laporan insiden, laporan bahaya dan risiko, statistik kesehatan kerja yang dikelompokkan, klaim kompensasi pekerja, survei pekerja, ketidakhadiran dan pergantian pekerja data.

CATATAN 1 Jika informasi terdokumentasi dapat mengidentifikasi pekerja tertentu, penting untuk mengumpulkan (mengelompokkan) data untuk memastikan privasi pekerja individu dihormati dan pekerja tertentu tidak dapat diidentifikasi. Organisasi diharapkan untuk mempertimbangkan pengetahuan, keahlian dan kompetensi pekerja dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka dan berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan pekerja yang relevan, di mana mereka ada, dalam identifikasi bahaya psikososial dan bagaimana pekerjaan mereka dirancang dan dilakukan.

Ketika mengidentifikasi bahaya psikososial, organisasi harus memperhitungkan bahwa bahaya psikososial berinteraksi satu sama lain dan dengan jenis bahaya lain di lingkungan kerja. Misalnya, bahaya psikososial dapat meningkatkan risiko paparan bahaya lain melalui kesalahan manusia, peningkatan tekanan waktu, atau ekspektasi sosial/budaya tentang cara bekerja dengan bahaya lain. Lebih banyak efek buruk dapat terjadi dalam tingkat paparan yang sama ketika bekerja dalam kondisi yang mencakup risiko psikososial yang tidak terkendali.

Organisasi harus mempertimbangkan bagaimana paparan terhadap bahaya lain (misalnya bahaya biologis, kontaminan udara, bekerja di ketinggian, ruang terbatas) juga dapat berkontribusi terhadap risiko psikososial, karena pekerja dapat khawatir tentang kemungkinan implikasi dari paparan atau pengalaman tersebut. Tugas manual yang berbahaya (misalnya mengangkat, gerakan berulang) diketahui berinteraksi dengan bahaya psikososial dan mempengaruhi hasil seperti gangguan muskuloskeletal (MSD).

Organisasi harus mempertimbangkan faktor manusia dalam kaitannya dengan bahaya psikososial di semua bagian sistem manajemen K3. Faktor manusia mewakili kemampuan dan keterbatasan orang, dan oleh karena itu relevan dengan keberhasilan atau penilaian risiko, pengendalian risiko dan desain, implementasi, dan efektivitas tugas atau proses kerja. Kesadaran akan faktor manusia saat merancang dan mendesain ulang pekerjaan dapat menghasilkan hasil yang lebih positif dalam kaitannya dengan kesehatan dan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan.

Berbagai metode dapat digunakan untuk menganalisis faktor manusia yang relevan dengan tugas pekerjaan tertentu, termasuk observasi, konsultasi, teknik analisis tugas, dan audit khusus. Mengidentifikasi faktor manusia mana yang relevan dengan tugas kerja tertentu dapat, dalam beberapa keadaan, menjadi kompleks dan memerlukan saran atau pengetahuan khusus.

CATATAN 2 Informasi lebih lanjut tentang faktor manusia dapat ditemukan di [ISO 100752](#) dan [ISO6385](#).

6.1.2.2. Penilaian risiko dan peluang

Organisasi harus menilai risiko yang terkait dengan bahaya psikososial yang teridentifikasi (lihat [6.1.2](#)) dan mencari peluang untuk mengurangi risiko dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Penilaian ini harus:

- a) Memberikan informasi tentang potensi bahaya;
- b) Membandingkan kelompok yang berbeda dalam paparan, atau pelaporan, bahaya psikososial ;
- c) Mempertimbangkan interaksi risiko psikososial dengan risiko lain yang teridentifikasi bahaya;
- d) Memprioritaskan bahaya sesuai dengan tingkat risikonya;
- e) Mempertimbangkan keragaman tenaga kerja dan kebutuhan kelompok tertentu, serta konteks yang lebih luas dari organisasi;
- f) Memberikan informasi tentang tindakan pengendalian dan peluang untuk peningkatan.

6.2. Tujuan untuk mengatasi resiko psikososial

Organisasi harus:

- a) Menetapkan tujuan terukur yang konsisten dengan: aturan;
- b) Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memastikan bahwa tujuan ini dapat tercapai.

7. Dukungan

7.1. Sumber Daya

Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya sehubungan dengan pengelolaan risiko psikososial. Organisasi harus mempertimbangkan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan lainnya yang spesifik untuk operasinya.

7.2. Kompetensi

7.2.1. Organisasi Sebaiknya:

- a) Mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mengidentifikasi bahaya psikososial dan mengelola risiko psikososial (misalnya memahami bagaimana bahaya psikososial dapat berinteraksi satu sama lain dan bahaya lainnya, serta sifat dan ruang lingkup hasil potensialnya);
- b) Mengambil tindakan, termasuk pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai, untuk mendukung pekerja memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan;
- c) Memastikan bahwa pekerja dan pihak berkepentingan terkait lainnya memiliki kompetensi untuk menerapkan langkah-langkah dan proses yang diperlukan untuk pencegahan risiko psikososial;
- d) Memastikan bahwa pekerja dan pihak berkepentingan terkait lainnya memahami proses pelaporan atau peningkatan kekhawatiran;
- e) Mencari saran eksternal yang relevan jika pengetahuan ini tidak tersedia di organisasi;
- f) Mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil untuk memastikan kompetensi;
- g) Memperhitungkan kebutuhan, pengalaman, keterampilan bahasa, literasi dan keragaman pekerja individu

7.2.2. Organisasi harus menetapkan persyaratan kompetensi untuk:

- a) Tanggung jawab Manajemen puncak dan pekerja dengan manajemen lini;
- b) Pekerja yang melakukan penilaian risiko;
- c) Pekerja yang menerapkan tindakan pengendalian dan intervensi lainnya (lihat [8.1.1](#));
- d) Pekerja yang melakukan evaluasi dan tinjauan proses dan hasil.

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang berkaitan dengan kompetensi, termasuk pelatihan dan tindakan lain yang diambil, dan berkonsultasi dengan pekerja ketika menentukan kompetensi yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengelola risiko psikososial.

7.3. Kesadaran

7.3.1. Jika sesuai, organisasi harus memberi tahu pekerja dan pihak berkepentingan terkait lainnya tentang faktor-faktor di tempat kerja yang dapat:

- a) Mempengaruhi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja;
- b) Berpotensi menciptakan atau meningkatkan stigma dan/atau diskriminasi;
- c) Mengurangi risiko psikososial;
- d) Mendukung peran dan tanggung jawab mereka untuk mempromosikan kesehatan dan keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan di bekerja

7.3.2. Ketika mengembangkan kesadaran akan risiko psikososial, organisasi harus mempertimbangkan:

- a) Pentingnya dukungan manajemen puncak untuk melaporkan bahaya psikososial dan perlindungan dari pembalasan untuk pelaporan tersebut;
- b) Tindakan yang pekerja dapat lakukan untuk bahaya psikososial dan bagaimana organisasi diharapkan untuk menanggapi;
- c) Manfaat potensial dengan membagikan pengalaman dan prakteknya kepada pekerja dan pihak terkait lainnya;
- d) Pengetahuan dan pelatihan yang ada bagi pekerja dan pihak terkait lainnya;
- e) Kebutuhan untuk menanamkan dan mengintegrasikan kesadaran akan risiko psikososial dalam proses dan kebijakan (misalnya selama pekerja baru orientasi);
- f) Kesempatan yang diberikan oleh acara dan pertemuan yang ada (misalnya acara seluruh organisasi, pertemuan staf reguler);
- g) Risiko, peluang, dan dampak yang timbul dari perubahan dalam tempat kerja;
- h) Kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk menghilangkan stigma dan/atau diskriminasi.

Organisasi harus membuat pekerja dan pihak berkepentingan lainnya menyadari tindakan yang diambil untuk mengelola risiko psikososial, termasuk tindakan untuk mendorong pelaporan bahaya psikososial, mengurangi rasa takut akan pembalasan yang terkait dengan pelaporan, dan meningkatkan kepercayaan pada sistem manajemen K3.

7.4. Komunikasi

Komunikasi penting karena menunjukkan komitmen untuk mengelola risiko psikososial, mempromosikan kesejahteraan di tempat kerja, dan menginformasikan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya tentang apa yang diharapkan dari mereka, dan apa yang dapat mereka harapkan dari organisasi.

Organisasi harus mengomunikasikan kepada pekerja dan pihak terkait lainnya informasi tentang risiko psikososial yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan. Ketika berkomunikasi, organisasi harus:

- a) Menunjukkan komitmen manajemen puncak kepada pekerja lain, untuk meningkatkan pengetahuan dan penggunaan proses;
- b) Memberikan kesempatan untuk umpan balik kepada manajemen puncak dari pekerja tentang tindakan, program dan kebijakan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerja keterlibatan;
- c) Menguraikan pengembangan prosesnya untuk mengelola risiko psikososial dan efektivitasnya;
- d) Menanggapi ide dan kekhawatiran pekerja dan pihak berkepentingan lainnya dan masukan mereka ke sistem manajemen k3 sehubungan dengan risiko psikososial;
- e) Memasukkan informasi tentang bagaimana perubahan terkait pekerjaan dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di bekerja;
- f) Memberikan informasi dari audit dan evaluasi lainnya.

Informasi yang relevan harus dapat diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerja (misalnya dalam bahasa yang berbeda atau menggunakan media yang berbeda seperti klip video atau file audio).

7.5. Informasi Terdokumentasi

7.5.1. Umum

Sistem manajemen K3 organisasi harus mencakup informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk manajemen risiko psikososial yang efektif.

Informasi terdokumentasi meliputi:

- a) Proses untuk pengelolaan risiko psikososial;
- b) Rincian peran, tanggung jawab dan wewenang;
- c) Penilaian risiko psikososial;
- d) Hasil pemantauan, evaluasi, tindakan pengendalian dan efektivitas;
- e) Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

7.5.2. Kerahasiaan

Organisasi harus menetapkan proses yang terkait dengan risiko psikososial yang memastikan kerahasiaan informasi pribadi dengan memperhatikan persyaratan hukum yang relevan dan persyaratan lainnya.

Organisasi harus:

- a) Menjaga kerahasiaan informasi terdokumentasi dan tidak terdokumentasi sehubungan dengan pengalaman psikososial pekerja individu;
- b) Melindungi dari pengungkapan hasil setelah terpapar bahaya psikososial (seperti perawatan medis, waktu tidak bekerja, pengaturan kerja yang fleksibel) dan informasi medis;
- c) Memberi tahu pekerja tentang batasan apa pun yang berlaku untuk kerahasiaan.

8. Operasi

8.1. Perencanaan Operasional dan Kontrol

8.1.1. Umum

8.1.1.1. Organisasi harus merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan memelihara proses untuk mengelola risiko psikososial dan peluang baru secara memadai dan efektif, termasuk tindakan atau kegiatan untuk :

- a) Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko psikososial dengan mempertimbangkan kecocokan terbaik antara tugas, struktur dan proses kerja serta kebutuhan pekerja;
- b) Menganalisis kontrol yang sudah ada untuk mengelola risiko psikososial dan pengaruhnya terhadap individu atau organisasi;
- c) Meninjau, menganalisis, dan mengevaluasi praktik manajemen yang ada dan dukungan pekerja untuk mengendalikan bahaya psikososial, stres terkait pekerjaan, dan kesehatan terkait lainnya hasil;
- d) Mengadopsi strategi jangka panjang yang komprehensif yang mempertimbangkan kebijakan, struktur, sumber daya, sistem dan operasi organisasi yang ada, dan praktek;
- e) Merancang dan mengelola pekerjaan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan dan keselamatan psikologis dan untuk meningkatkan kesejahteraan di bekerja.

8.1.1.2 Organisasi harus menyelesaikan penilaian risiko psikososial, dengan mempertimbangkan kontrol yang ada, untuk:

- a) Menentukan apakah pengendalian ini memadai atau perlu peningkatan;
- b) Menilai apakah pengendalian baru diperlukan jika penilaian risiko psikososial telah mengidentifikasi bahaya aktual atau potensial dari paparan bahaya psikososial ;
- c) Menghilangkan bahaya psikososial terkait pekerjaan sedapat mungkin, dan mengendalikan risiko terkait jika eliminasi tidak memungkinkan, mengikuti prinsip hierarki kontrol (lihat [ISO 45001:2018, Klausul 8](#)).

8.1.1.3. Saat mengelola risiko psikososial, kombinasi tingkat intervensi berikut dapat digunakan:

- a) Primer: tingkat kontrol organisasi untuk mencegah atau mengurangi efek berbahaya dan meningkatkan kesejahteraan di tempat kerja;
- b) Sekunder: meningkatkan sumber daya yang membantu pekerja menghadapi risiko psikososial dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman melalui pelatihan yang efektif dan tindakan lain yang sesuai;
- c) Tersier: mengurangi efek berbahaya dari paparan bahaya psikososial dengan menerapkan program rehabilitasi dan mengambil tindakan korektif dan suportif lainnya tindakan.

CATATAN 1 Beberapa organisasi memiliki layanan kesehatan kerja atau program bantuan pekerjanya sendiri. Organisasi yang tidak memiliki keahlian internal dapat meminta bantuan dari sumber eksternal yang kompeten, jika diperlukan.

CATATAN 2 Tiga tingkat intervensi primer, sekunder dan tersier mencerminkan hierarki kontrol untuk mendukung manajemen risiko psikososial yang efektif.

8.1.2. Menghilangkan Bahaya, Mengurangi Risiko K3 dan Meningkatkan Kesejahteraan di Tempat Kerja

8.1.2.1. Pengukuran Pengendalian Risiko Psikososial

Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko psikososial meningkatkan kesejahteraan di tempat kerja. Ada berbagai strategi untuk mengelola risiko psikososial dan mempromosikan K3. Strategi untuk menghilangkan bahaya, mengurangi risiko psikososial dan mempromosikan kesejahteraan harus dikembangkan melalui konsultasi dengan pekerja dan, perwakilan pekerja jika ada.

8.1.2.2. Langkah-Langkah Pengendalian Risiko Psikososial yang Terkait dengan Pekerjaan Organisasi

Organisasi harus menerapkan langkah- langkah pengendalian untuk risiko psikososial yang terkait dengan organisasi kerja. Dalam banyak kasus, ini membutuhkan desain ulang proses kerja, tidak hanya penyesuaian tugas. Tindakan dapat mencakup: Meningkatkan kontrol pekerja atas cara mereka melakukan pekerjaan mereka, misalnya dengan memperkenalkan kerja yang fleksibel, pembagian kerja, lebih banyak konsultasi tentang praktik kerja atau memungkinkan pekerja untuk mengontrol kecepatan kerja tugas;

- a) Mengizinkan istirahat untuk mengatasi kelelahan, dan membatasi kontak terkait pekerjaan melalui telepon seluler dan email di waktu tidak bekerja;
- b) Konsultasi pekerja dan, perwakilan pekerja jika ada, tentang tempat kerja perubahan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi mereka;
- c) Mendefinisikan peran kerja, pengawasan hubungan dan persyaratan penilaian meminimalkan kebingungan dan ambigu
- d) Memprioritaskan tugas dan memungkinkan kerangka waktu yang fleksibel untuk penyelesaian;
- e) Memfasilitasi pengembangan kompetensi dan mengalokasikan tugas kerja kepada pekerja dengan pengetahuan yang tepat, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan kompleksitas dan durasi dari tugas;
- f) Memberikan akses yang lebih besar pada dukungan sosial bagi pekerja yang bekerja dari jarak jauh atau bekerja di lokasi kerja yang terisolasi;
- g) Membatasi pekerjaan jarak jauh dan/atau terisolasi, jika sesuai;
- h) Memberikan pengawasan yang efektif, umpan balik dan bimbingan yang konstruktif untuk pekerja;
- i) Meningkatkan sikap terhadap pengelolaan dan pelaporan risiko psikososial, termasuk stres terkait pekerjaan, pelecehan, intimidasi, dan kekerasan di tempat kerja;
- j) Memberikan dukungan praktis selama periode beban kerja puncak (misalnya tambahan atau pekerja yang lebih berpengalaman).

8.1.2.3. Langkah-Langkah Pengendalian Risiko Psikososial Terkait dengan Faktor Sosial

Organisasi harus menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk risiko psikososial yang terkait dengan faktor sosial di tempat kerja. Tindakan dapat mencakup:

Meningkat kesadaran dari risiko psikososial dan menyediakan informasi dan pelatihan kepada pekerja tentang cara melaporkan mereka;

- a) Mendorong pelaporan dini masalah pekerja dengan menunjukkan komitmen organisasi untuk menyediakan lingkungan kerja yang mendukung, saling menghormati, dan menjaga kerahasiaan;
- b) Menetapkan langkah-langkah dukungan bagi pekerja yang mengalami dampak negatif dari paparan risiko psikososial;
- c) Mengembangkan kebijakan dan panduan organisasi yang menguraikan perilaku kerja yang diharapkan dan bagaimana perilaku yang tidak dapat diterima dikelola;
- d) Memberikan instruksi khusus tentang bagaimana mengelola risiko yang dapat diperkirakan, bagaimana menanggapi jika suatu insiden terjadi, dan bagaimana memberikan bantuan pascainsiden kepada pekerja;
- e) Memberikan pelatihan untuk mengembangkan kesadaran dan keterampilan yang tepat untuk mengidentifikasi risiko psikososial dan mengenali tanda-tanda awal stres terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk;
- f) Menyediakan akses ke, atau informasi tentang, layanan dukungan, layanan kesehatan kerja umum, pembekalan rahasia, konseling dan mediasi konflik jasa;
- g) Memberikan informasi kepada pekerja tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka;
- h) Mengakui dan menghargai komitmen dan pencapaian pekerja;
- i) Meningkatkan budaya tempat kerja melalui serangkaian program terpadu (misalnya praktik manajemen kesehatan dan keselamatan, tanggung jawab sosial, kelestarian lingkungan, pelibatan masyarakat);
- j) Mempromosikan tempat kerja yang bebas dari kekerasan terkait pekerjaan dan gangguan;
- k) Memberi para korban kekerasan dan pelecehan terkait pekerjaan (termasuk kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual) akses ke dukungan yang responsif dan dukungan pelayanan yang aman.

8.1.2.4. Tindakan Pengendalian Risiko Psikososial Terkait dengan Lingkungan Kerja, Peralatan dan Bahaya Tugas

Organisasi harus menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk risiko psikososial yang terkait dengan lingkungan kerja, peralatan dan tugas berbahaya, termasuk:

- a) Menyediakan, dan memelihara peralatan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan (mis peralatan penanganan manual) dan meningkatkan peralatan seperlunya;
- b) Meningkatkan lingkungan tempat kerja dan fitur fisik tempat kerja untuk mengisolasi atau melindungi pekerja dari bahaya (misalnya kebisingan, pencahayaan, getaran, suhu, bahan kimia);
- c) Mengisolasi atau melindungi pekerja dari bahaya psikososial, misalnya dengan penghalang fisik untuk mengurangi risiko kekerasan;
- d) Menyediakan dan membutuhkan penggunaan peralatan pelindung diri (APD) yang efektif di mana ada risiko yang tidak dapat diminimalkan dengan menggunakan kontrol tingkat tinggi yang lebih efektif.

CATATAN APD yang sesuai dapat mengurangi kekhawatiran pekerja tentang paparan berbagai bahaya lain dan dapat berkontribusi untuk mengendalikan dan mengurangi risiko psikososial yang terkait dengan lingkungan kerja, peralatan, dan tugas berbahaya (lihat [Tabel 3](#)).

8.1.2.5. Tanda-Tanda Paparan Risiko Psikososial

Organisasi harus memungkinkan pekerja untuk mengidentifikasi tanda-tanda paparan risiko psikososial. Contoh di tingkat individu dan/atau kelompok dapat mencakup:

- a) Perubahan perilaku;
- b) Isolasi atau penarikan sosial, menolak tawaran bantuan atau mengabaikan kebutuhan kesejahteraan pribadi;
- c) Peningkatan ketidakhadiran dari pekerjaan atau masuk kerja ketika sakit;
- d) Kurangnya keterlibatan pekerja;
- e) Energi berkurang;
- f) Pergantian Staf tinggi;
- g) Kinerja berkualitas rendah atau kegagalan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu;
- h) Berkurangnya keinginan untuk bekerja dengan orang lain;
- i) Konflik, kurangnya kemauan untuk bekerja sama, dan intimidasi;
- j) Peningkatan frekuensi insiden atau kesalahan

8.1.3. Manajemen Perubahan

Perubahan organisasi dan terkait pekerjaan dapat mempengaruhi risiko psikososial atau menciptakan risiko psikososial tambahan. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk komunikasi dan pengendalian perubahan yang dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja, termasuk:

- a) Perubahan pada tujuan organisasi, kegiatan, proses kerja dan kepemimpinan, (misalnya lokasi dan lingkungan tempat kerja; peralatan dan sumber daya; tenaga kerja dan persyaratan kerja);
- b) Perubahan pada tugas kerja dan organisasi (misalnya pola shift, alur kerja, alur pelaporan) dan kondisi pekerjaan;
- c) Perubahan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
- d) Perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko psikososial;
- e) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perlunya peningkatan kompetensi melalui penambahan pelatihan;

Organisasi harus melibatkan pekerja dan perwakilan pekerja, jika ada, pada tahap awal proses perubahan dan selama proses, khususnya selama restrukturisasi

8.1.4. Pengadaan, Kontrak dan Outsourcing

Pengadaan produk dan jasa dan kontrak untuk, dan outsourcing, kegiatan dapat mempengaruhi risiko psikososial yang ada dan menciptakan risiko baru atau peluang baru. Organisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengendalikan risiko psikososial yang timbul dari paparan bahaya yang terkait dengan pengadaan, kontrak, dan outsourcing, yang mempertimbangkan:

- a) Bagaimana pengadaan produk dan jasa menciptakan risiko ini (misalnya melalui kehadiran pengunjung di tempat kerja atau penjadwalan pengiriman produk dan layanan yang berdampak pada jadwal kerja organisasi dan beban kerja, kinerja, dan pelatihan pekerja kebutuhan);
- b) Bagaimana keterlibatan kontraktor dapat memengaruhi budaya tempat kerja, peran dan harapan pekerja;
- c) Bagaimana kegiatan outsourcing berdampak pada jadwal, beban kerja, perubahan tugas kerja, keamanan kerja, pengawasan atau kualitas bekerja;

Bagaimana tugas bersama untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja dikelola oleh organisasi, kontraktor dan pemasoknya, dan pihak berkepentingan lainnya .

8.2. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Organisasi harus mempertimbangkan bahwa keadaan darurat di tempat kerja dapat menimbulkan risiko psikososial (misalnya melalui trauma, ancaman terhadap kehidupan). Paparan risiko psikososial juga dapat menciptakan situasi darurat (misalnya kekerasan, ancaman) bagi pekerja lain dan pihak berkepentingan lainnya.

Untuk memastikan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja dan mengelola risiko psikososial dalam keadaan darurat (misalnya bencana alam, penyakit menular yang muncul, bunuh diri rekan kerja, insiden, krisis, teror, ancaman, perampokan, pemecatan, penutupan perusahaan, pemecatan), organisasi harus:

- a) Menyadari bahwa berbagai situasi darurat dapat berdampak psikologis kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan;
- b) Mempersiapkan untuk memasukkan perawatan yang tepat dalam respon yang direncanakan untuk situasi keadaan darurat;
- c) Menentukan prioritas saat menanggapi kebutuhan dari pekerja dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan;
- d) Menggunakan pekerja yang kompeten, jasa keadaan darurat atau spesialis lainnya yang sesuai untuk menanggapi untuk situasi darurat dan mencari saran dan dukungan tambahan sesuai kebutuhan.

8.3. Rehabilitasi dan Kembali Bekerja

Organisasi harus merancang dan menerapkan program rehabilitasi dan program kembali bekerja yang sesuai. Program rehabilitasi dan kembali bekerja bertujuan untuk memberikan dukungan yang sesuai kepada pekerja yang mengalami dampak negatif dari paparan bahaya psikososial, termasuk yang mengakibatkan ketidakhadiran kerja. Ketika merancang program-program ini, organisasi harus mempertimbangkan bahwa pekerja dapat meningkatkan potensi paparan risiko psikososial sebagai bagian dari proses kembali bekerja. Misalnya, penyesuaian kerja untuk memfasilitasi kembali bekerja dapat mengakibatkan perubahan tugas pekerjaan, hubungan dan interaksi sosial, pengawasan, budaya kerja, dan persepsi pencapaian dan nilai di tempat kerja. Potensi peningkatan paparan risiko psikososial berlaku untuk pekerja yang kembali bekerja terlepas dari alasan ketidakhadiran mereka.

Respons awal dan suportif terhadap pekerja yang terkena dampak negatif adalah penting. Organisasi dapat mendorong pelaporan dini masalah dengan menunjukkan komitmen untuk menjaga kerahasiaan dan menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan saling menghormati (lihat [Klausul 5](#)).

Potensi paparan risiko psikososial selama kembali bekerja harus dikelola dengan cara yang konsisten dengan bagaimana semua risiko psikososial harus dicegah dan dikelola

Contoh tindakan untuk meningkatkan rehabilitasi dan kembali bekerja meliputi:

- a) Menyediakan akses ke, atau informasi tentang, layanan kesehatan kerja umum, baik internal maupun eksternal kepada: organisasi;
- b) Menyediakan akses ke, atau informasi tentang, tanya jawab rahasia, layanan konseling, layanan mediasi konflik, dan akses ke penilaian yang relevan dll.;
- c) Berbicara dengan pekerja yang terkena dampak untuk memahami dan merencanakan penyesuaian kerja yang wajar untuk mendukung kembali ke bekerja;
- d) Memastikan pekerja dengan peran manajemen kompeten untuk mengelola dampak paparan bahaya psikososial dan memahami persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lain saat pekerja kembali ke bekerja;
- e) Secara teratur memantau rehabilitasi dan program kembali bekerja untuk menetapkan jika ada yang baru atau yang sebelumnya tidak teridentifikasi risiko;
- f) Berkonsultasi dengan pihak berkepentingan terkait lainnya, termasuk profesional kesehatan kerja, dalam mengelola proses kembali bekerja mengenai kemajuan dan perubahan yang diperlukan untuk kembali bekerja program.

9. Evaluasi Kinerja

9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis, dan Kinerja Evaluasi

9.1. Organisasi harus menetapkan dan menerapkan pendekatan sistematis untuk memantau dan mengukur aktivitas yang terkait dengan pengelolaan risiko psikososial dan kinerja sistem manajemen K3.

Pemantauan dan pengukuran kinerja harus:

- a) Menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dipatuhi dan sesuai dengan tujuannya;
- b) Memberikan data tentang kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan psikologis di tempat kerja, mengakui perlunya kerahasiaan informasi pribadi;
- c) Menentukan apakah proses untuk identifikasi bahaya psikososial dan penilaian risiko ada dan kontrol beroperasi secara efektif (misalnya dengan mempertimbangkan tanda-tanda paparan pekerja terhadap risiko psikososial sebagaimana diatur dalam [8.1.2.5](#));
- d) Memberikan dasar untuk keputusan tentang perbaikan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja;
- e) Menentukan cakupan dimana organisasi wajib memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
- f) Memberikan informasi tentang kinerja sistem manajemen k3 dalam mengelola risiko psikososial.

Organisasi harus mengembangkan langkah-langkah kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dengan berkonsultasi dan dengan partisipasi pekerja dan, perwakilan pekerja, jika ada.

9.1.2. Organisasi harus memelihara, memantau, meninjau, dan merevisi bila perlu tindakan pengendalian risiko psikososial untuk memastikan tindakan tersebut tetap efektif. Ulasan harus terjadi:

- a) Jika bahaya atau risiko baru ditemukan;
- b) Jika tindakan pengendalian tidak memadai untuk meminimalkan mempertaruhkan;
- c) Sebelum perubahan tempat kerja yang signifikan (misalnya perubahan lingkungan kerja atau sistem kerja);
- d) Di mana konsultasi menunjukkan sebuah tinjauan adalah diperlukan atau pekerja atau pekerja perwakilan meminta tinjauan.

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti hasil pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja.

Organisasi harus menetapkan indikator kinerja utama dan mengumpulkan serta menganalisis data yang relevan. Indikator utama memungkinkan prediksi kinerja masa depan dan harus digunakan sebagai tambahan indikator tertinggal yang menunjukkan peningkatan terhadap kinerja masa lalu.

9.2. Intern Audit

Organisasi harus:

- a) Melakukan audit internal pada interval yang direncanakan termasuk pertimbangan risiko psikososial;
- b) Menggunakan temuan untuk menilai efektivitas pengelolaan risiko psikososial;
- c) Mengidentifikasi kesenjangan dalam kinerja untuk mengidentifikasi peluang untuk terus meningkatkan pengelolaan risiko psikososial

9.3. Tinjauan Manajemen

9.3.1. Tinjauan manajemen memastikan bahwa manajemen puncak tetap mendapat informasi tentang kinerja risiko psikososial secara teratur dan sejauh mana organisasi telah memenuhi kebijakan dan tujuannya untuk pengelolaan risiko psikososial. Hasil dari pemantauan dan pengukuran memberikan dasar untuk analisis selama proses tinjauan manajemen dan digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan kecukupan, kesesuaian dan efektivitas kegiatannya untuk mengelola risiko psikososial. Pengambilan keputusan berbasis bukti adalah kunci untuk terus meningkatkan efektivitas sistem manajemen K3.

Manajemen puncak harus:

- a) Meninjau manajemen organisasi risiko psikososial sesuai rencana interval;
- b) Menggunakan hasil dari analisis dan evaluasi selama tinjauan manajemen proses;
- c) Mengevaluasi keseluruhan kecukupan, kesesuaian dan efektivitas kegiatannya untuk mengelola risiko psikososial;
- d) Menilai peluang untuk peningkatan dan kebutuhan untuk perubahan, dan menggunakan itu hasil dari tinjauan manajemen sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan kegiatan;
- e) Menyimpan informasi terdokumentasi dari manajemen ulasan.

9.3.2. Masukan untuk tinjauan manajemen yang berkaitan dengan risiko psikososial harus termasuk:

- a) Hasil dari audit dan evaluasi dari kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lain yang berlaku sesuai tujuan organisasi;
- b) Hasil partisipasi dan konsultasi;
- c) Kinerja risiko psikososial dari organisasi;
- d) Data K3 dan data lainnya (misalnya layanan dukungan, rencana disabilitas, kompensasi skema);
- e) Status investigasi kecelakaan dan tindakan perbaikan yang diambil untuk mencegah risiko psikososial untuk pekerja.

Manajemen puncak harus mengomunikasikan hasil tinjauan manajemen yang relevan sehubungan dengan risiko psikososial kepada pekerja dan pihak berkepentingan lainnya, sebagaimana mestinya.

10. Peningkatan

10.1. Umum

Saat menerapkan tindakan untuk terus meningkatkan sistem dan kinerja manajemen K3 dalam kaitannya dengan risiko psikososial, organisasi harus mempertimbangkan hasil dari:

- a) Evaluasi kinerja;
- b) Kejadian laporan;
- c) Konsultasi dan rekomendasi dari pekerja dan, perwakilan pekerja jika ada;
- d) Audit;
- e) Tinjauan Manajemen.

Organisasi harus mengevaluasi efektivitas tindakan perbaikan.

10.2. Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

Organisasi harus:

- a) Memiliki proses untuk mengatasi ketidaksesuaian dan insiden yang terkait dengan risiko psikososial;
- b) Mempertimbangkan untuk mengembangkan proses khusus untuk menyelidiki ketidaksesuaian dan insiden mengingat sifat sensitif dari insiden yang berdampak pada kesehatan psikologis, keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja;
- c) Menentukan proses untuk pelaporan ketidaksesuaian dan insiden yang menjaga kerahasiaan dan memberikan tanggapan yang tepat waktu untuk laporan;
- d) Mendorong dan mendukung pelaporan untuk mengurangi rasa takut terhadap pembalasan;
- e) Menggunakan informasi yang diperoleh dari investigasi dan rekomendasi untuk tindakan korektif untuk mengidentifikasi peluang untuk peningkatan

CATATAN Ketidaksesuaian terjadi setiap kali ada ketidaksesuaian aktual atau potensial terhadap persyaratan sistem manajemen K3 organisasi. Sebuah insiden terjadi setiap kali ada aktual, atau potensi, cedera atau kesehatan yang buruk untuk seorang pekerja

10.3. Peningkatan Terus-Menerus

Organisasi harus:

- a) Mengumpulkan informasi tentang peluang untuk perbaikan dalam pengelolaan risiko psikososial, pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, dan pencapaian tujuan K3 sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan;
- b) Mengevaluasi peluang untuk menerapkan perubahan dan memberikan prioritas kepada potensi yang paling besar untuk meningkatkan psikologis kesehatan, keamanan dan kesejahteraan di tempat kerja.